

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : نجلاء فتحى رياض محمد

المحافضة : الحيزه

الحى / المدينة : يولاق الذكرور

العنوان : ---

تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

رقم البطاقة : 27407072101981 رقم التلفون : 01147212726

العمر (تاريخ الميلاد): 07-07-1974 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

**قسم العلاج :
الاورام**

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات الاروماتاز [14161]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:

الوظيفة:

الوظيفة:

التوقيع:

التوقيع:

التوقع:

تتعمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / ۲ ----- / ۲ ----- / ۲. | ----- / ۲. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جھة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :
نفقات

نَفَقَات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نجلاء فتحي رياض محمد National ID: 27407072101981	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة لمطابق الشخصية



لجلاء

فتحى رياض محمد

١٩ ش الشاذلى - الطالبة البحرية

بولاق الدكرور - الجيزة



٢٧٤٠٧٠٧٢١٠١٩٨١

LW7470287

ID ms

رئيس

مهاجرين



٢٠٢٦/٠٨

٩٧٤٠٧٠٧٢١٠٩٨٨١

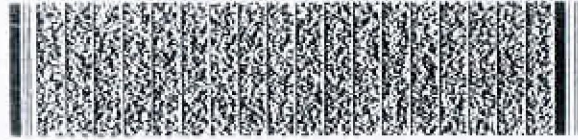
حاصلة على دبلوم تمريض

مستلمة

النش



البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٨/٠٢



Name: <u>نجلاء فتحى رياض محمد</u>		
MR. : <u>87</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها		
The patient was evaluated for metastatic breast cancer to bone and was scheduled to receive arimidix with supplemental treatment for CT abdomen and pelvis; a free bone scan and right chest CT were ordered. A bone scan performed on 5-3-2026 showed no evidence of skeletal metastatic disease, but demonstrated degenerative and arthritic changes at multiple spinal levels, both shoulders, and weight-bearing joints. Orthopedic consultation was obtained, and the patient was prescribed femara with supplemental treatment planned for three months. The patient has a history of left-sided invasive ductal carcinoma, estrogen- and progesterone-receptor positive (ER 8/8, PR 8/8), HER2 negative, staged cT3N1M0. Neoadjuvant chemotherapy consisted of four cycles of AC followed by 12 weeks of taxol. She subsequently underwent left skin-sparing mastectomy with sentinel lymph node biopsy on 5/2024, pathology revealed ypT2 ypN0, and she received postoperative radiation therapy. Adjuvant aromatase inhibitor therapy has been continued since then. The patient was admitted to the ICU in February 2026 with septic arthritis of the right knee; imaging at that time suggested possible bone metastases, but a bone scan on 3/2026 showed only arthritic changes. She remains on femara with supplemental treatment for three months and is scheduled for a CT chest-abdomen-pelvis to further evaluate for metastatic disease. To date, the patient has completed four cycles of AC and twelve weeks of taxol.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	Reham Ahmed Fathy Ibrahim	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name	: الأستاذة / نجلاء فتحي رياض محمد	Request No.	: 13008203
Patient No.	: 27407072101981	Request Date	: 19/11/2024
Path No.	: 4490/24	Verification Date	: 04/12/2024
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 50 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

dermis.

- * Lymph node involvement: Free (0/7).
- * Resection Margins: Free deep resection margin.
- * Histologic response to therapy: Partial pathological response.
- * Microcalcifications: Positive.
- * Additional pathologic findings: There are necrosis, hyalinosis and hemosiderin laden macrophages (effect of therapy).

Diagnosis:

- Left breast, simple mastectomy and SLNs Biopsy:
- Residual viable mixed invasive ductal and lobular carcinoma, grade II, with 2.5% insitu component.
 - Free deep resection margin.
 - Free nipple and areola epidermis, upper dermis, but infiltrated lower dermis.
 - Free sentinel lymph nodes (0/7).
 - Partial pathological response to therapy.
 - Stage: ypT2, ypN0.
 - RCB: 1.92, RCB class II.

Signature

Dr. Salma Tarek.

Dr. Toka Medhat.

Verified by :

Dr. Toka Medhat

Printing Date : 29/07/2025 09:18:02

Page 2 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / نجلاء فتحي رياض محمد	Request No. : 13008203
Patient No. : 27407072101981	Request Date : 19/11/2024
Path No. : 4490/24	Verification Date : 04/12/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 50 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

dermis.

- * Lymph node involvement: Free (0/7).
- * Resection Margins: Free deep resection margin.
- * Histologic response to therapy: Partial pathological response.
- * Microcalcifications: Positive.
- * Additional pathologic findings: There are necrosis, hyalinosis and hemosiderin laden macrophages (effect of therapy).

Diagnosis:

- Left breast, simple mastectomy and SLNs Biopsy:
- Residual viable mixed invasive ductal and lobular carcinoma, grade II, with 2.5% insitu component.
 - Free deep resection margin.
 - Free nipple and areola epidermis, upper dermis, but infiltrated lower dermis.
 - Free sentinel lymph nodes (0/7).
 - Partial pathological response to therapy.
 - Stage: ypT2, ypN0.
 - RCB: 1.92, RCB class II.

Signature
Dr. Salma Tarek.
Dr. Toka Medhat.

Verified by :

Printing Date : 05/01/2025 13:49:14

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنوش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

PATIENT NAME: NAGLAA FATHY REYAD MOHAMMED

GENDER: Female

DATE : 07-May-2024 10:38 AM

PATIENT ID: 10124241833

AGE: 49 y

ORDER: 2833774

Whole body [18F] FDG PET-CT Scan**CLINICAL HISTORY:**

-49 years old patient, presented with left breast lesion (BIRADS 5).

Reason for the study: detection of FDG avid neoplastic lesions.

TECHNIQUE:

- Radiopharmaceutical: 18F FDG, 6.2 mCi intravenously.
- Time from 18F-FDG injection to scan: 60 min
- PET/CT images were acquired from the skull through the upper thighs & CT images were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- No IV contrast was given
- Patient's weight: 88 Kg - Patient's height: 162 cm - Bl. Gluc. Level: 98 mg/dL.
- Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.
* Reference hepatic activity (SUV max):- 2.63

FINDINGS:**Breast & Axilla:**

- Mild increased FDG uptake by left breast retro-areolar ill-defined lesion reaching the nipple measuring about 4 x 2 cm and SUVmax 2.22.
- Few small subcentimetric left axillary level I lymph nodes showing low grade metabolic activity of SUV max 1.1.
- Solitary right axillary mild metabolically active level I lymph node is seen measuring 2.7 x 1.8 cm and with SUVmax~2.68.
- No right breast metabolically active (FDG avid) lesions.

Head and Neck:

- Normal diffuse brain activity with no hypermetabolic brain lesions.
- Physiologic FDG uptake is seen in submandibular and parotid salivary glands.
- Normal appearance of thyroid gland with no FDG avid nodules detected.
- No current definite hypermetabolic or pathologically enlarged cervical lymphadenopathy.





جمهورية مصر العربية
بطاقة تحتي الشخصية

نخلاء

فضي رياض محمد

١٩ ش السلاسل الطابية البحرية

بولاق الكروز - الجيزة

٨٩٧٤/٠٧

٢٧٤٠٧٠٧٢١٠١٩٨١

LW7470287



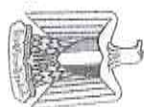
٢٠٢٦/٠٨

٢٧٤٠٧٠٧٢١٠١٩٨١

حضانة على بلوم تعريض

مسلية

أنش



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٨/٠٧

